Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

GENEFOOD JUNIOR

Sig. Piccolo Junior

N° ACCETTAZIONE 12345678	**DATA DI REFERTAZIONE** 30/09/2024 13:03:36	
DATA DI NASCITA 19/02/2019	**SESSO** M	
PESO (kg): 25	**STATURA (cm):** 110	**BMI:** 20.66 (Normopeso)

Sintesi degli esiti rilevati sulla base delle condizioni genetiche indagate:

SINDROME METABOLICA (MetS)
PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA SINDROME METABOLICA

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE INTOLLERANZE
PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UNA ELEVATA SENSIBILITA' ALLA CAFFEINA

INSORGENZA DI CARIE
NON SI EVIDENZIANO PREDISPOSIZIONI GENETICHE

DISFUNZIONI METABOLICHE VITAMINE/MINERALI E FRAGILITA' OSSEA
NON SI EVIDENZIANO PREDISPOSIZIONI GENETICHE

Prof. Dott. Alvaro Mesoraca
Specialista in Genetica Medica

Dott.ssa Katia Margiotti, PhD
Specialista in Genetica Medica

N.B. La sintesi sopra riportata non è una diagnosi clinica (le diagnosi cliniche spettano esclusivamente al medico).

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA SINDORME METABOLICA (MetS)

Negli ultimi anni, in concomitanza con l'aumento dei casi di obesità nell'età pediatrica, si è osservato un importante incremento della prevalenza di sindrome metabolica (MetS) nei bambini e negli adolescenti. La MetS è molto frequente e altera il peso anche in casi di sola alimentazione poco corretta e può alterare il metabolismo glicemico e lipidico fin dalla giovane età. Le modificazioni dello stile di vita, interessanti sia le abitudini alimentari che l'attività motoria, rimangono a tutt'oggi il punto cardine della gestione e del trattamento della MetS in età pediatrica e adolescenziale.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA SINDROME METABOLICA.

GENE	ALLELE		
	NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
APOE	T	C	**TT**
APOE	T	C	**TT**
FABP2	C	T	**CC**
Leptin	G	A	**GG**
ADIPOq	C	T	**CC**
FTO	T	A	**TT**
PPARG	C	G	**CC**
TCFL2	C	T	**CC**
GCK	C	T	**CC**
GCKR	C	T	**CC**
SLC30A8	T	C	**TT**
MTNR1B	C	G	**CC**
FTO	T	C	**TT**
APOA2	G	A	**GG**
MC4R	T	C	**TT**
LEPR	T	C	**TT**
TMEM18	T	C	**TT**
GNPDA2	A	G	**AA**
BDNF	C	T	**CC**
ADRB1	C	G	**CC**
FADS2	C	T	**CC**
FADS1	C	T	**CC**
CETP	T	G	**TT**
APOA5	A	G	**AA**
FTO	G	A	**GG**
FTO	T	A	**TT**
FTO	C	A	**CC**
MC4R	G	A	**GG**

GENE	SNP	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
MTHFR	rs1801133	G	A	**GG**
MTHFR	rs1801131	T	G	**TT**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE INTOLLERANZE

Le intolleranze alimentari in età pediatrica richiedono una gestione attenta e personalizzata. Un'adeguata diagnosi e un approccio dietetico corretto possono aiutare a minimizzare i sintomi e migliorare la qualità della vita dei bambini affetti. È fondamentale garantire un trattamento efficace e personalizzato considerando la componente genetica.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UNA ELEVATA SENSIBILITA' ALLA CAFFEINA.

GENE	ALLELE			MICRONUTRIENTE
	NORMALE	**PREDISPONENTE**	**PAZIENTE**	
ALDOB	G	T	**GG**	Fruttosio
ALDOB	C	G	**CC**	Fruttosio
LCT (MCM6)	A	G	**AA**	Lattosio
CLDN1	A	T	**AA**	Nichel
CLDN1	G	C	**GG**	Nichel
CLDN1	G	T	**GG**	Nichel
ALDH2	G	A	**GG**	Alcool
ADH1B*2	C	T	**CC**	Alcool
HLADQA1-B1	Normale	DQ8/DQ7.5/DQ2.5	**Normale**	Glutine

GENE	ALLELE			MICRONUTRIENTE
	METABOLIZZATORE VELOCE	**METABOLIZZATORE LENTO**	**PAZIENTE**	
CYP1A2	C	A	**CC**	Caffeina

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALL'INSORGENZA DI CARIE

La carie dentale è una malattia patologica multifattoriale considerata una delle malattie croniche più diffuse che colpisce sia i bambini che gli adulti. Varianti genetiche (SNPs) sono state associate all'aumentata prevalenza di carie così come alla ridotta prevalenza di carie. Alcune proteine codificate da geni specifici e presenti nella saliva sono state correlate alle risposte immunitarie individuali e possiedono proprietà antimicrobiche, antivirali, antifungine e/o antinfiammatorie.

IL TUO RISULTATO: NON SI EVIDENZIANO PREDISPOSIZIONI GENETICHE.

GENE	ALLELE		
	NORMALE	**PREDISPONENTE**	**PAZIENTE**
AMELX	C	T	**CC**
AMELX	C	T	**CC**
AMELX	C	T	**CC**
AMBN	G	T	**GG**
AMBN	T	C	**TT**
TUFT1	G	A	**GG**
KLK4	A	G	**AA**
KLK4	C	G	**CC**
KLK4	A	G	**AA**
KLK4	A	G	**AA**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA A DISFUNZIONI METABOLICHE VITAMINE/MINERALI E FRAGILITA' OSSEA

Le fratture pediatriche e/o giovanili sono comuni e spesso legate a traumi. Tuttavia, in alcuni bambini, queste fratture possono essere influenzate da fattori genetici.
Inoltre, minerali e vitamine sono essenziali per la salute ossea. Per esempio, la vitamina D è essenziale soprattutto in età pediatrica, poiché facilita l'assorbimento del calcio e del fosforo, minerali cruciali per la formazione e il mantenimento delle ossa.
È quindi importante conoscere una predisposizione genetica sin dall'infanzia a condizioni quali la fragilità ossea, per un trattamento efficace e personalizzato.

IL TUO RISULTATO: NON SI EVIDENZIANO PREDISPOSIZIONI GENETICHE.

GENE	FENOTIPO ASSOCIATO	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
HFE	Emocromatosi	C	G	**CC**
HFE	Emocromatosi	G	A	**GG**
TMPRSS6	Carenza di Ferro	G	A	**GG**
TMPRSS6	Carenza di Ferro	A	G	**AA**
COL1A1	Rischio Fragilità ossea (Tutte le età)	C	A	**CC**
LRP5	Rischio Fragilità ossea (Tutte le età)	C	T	**CC**
LRP5	Rischio Fragilità ossea (Tutte le età)	G	A	**GG**
VDR	Rischio Fragilità ossea (Tutte le età)	G	A	**GG**
PROSER2	Rischio Fragilità ossea (pediatrica)	G	C	**GG**
RIN3	Rischio Fragilità ossea (pediatrica)	G	C	**GG**
GC	Vitamina D	C	A	**CC**
GC	Vitamina D	T	C	**TT**
GC	Vitamina D	A	C	**AA**
GC	Vitamina D	C	A	**CC**
CYP2R1	Vitamina D	A	G	**AA**
DHCR7/NADSYN1	Vitamina D	G	T	**GG**
CSTA	Carenza di Fosforo	A	G	**AA**
IP6K3	Carenza di Fosforo	C	T	**CC**
CASR	Eccesso di Calcio	G	T	**GG**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

INFORMAZIONI ESSENZIALI A COMPLETAMENTO DEL TEST

Il test contempla uno studio mirato alle sole variazioni genetiche sulla cui corresponsabilità nell'insorgenza di patologie complesse vi è a sostegno una estesa letteratura scientifica. Questo test rappresenta un utilissimo strumento ai fini del tuo benessere. Va però sottolineato che **non rappresenta una diagnosi clinica, pertanto non sostituisce il parere del medico**. I risultati devono essere valutati ed approvati alla luce della storia anamnestica personale su **verifica del medico curante**.
N.B.L'elenco degli alimenti riportati è redatto in base al tuo profilo genetico e agli errori del metabolismo individuati.

Il test effettuato prende in considerazione le intolleranze ma non le allergie.

Bibliografia

Liù CC, Liu CC, Kanekiyo T, Xu H, Bu G (February 2013). *"Apolipoprotein E and Alzheimer disease: risk, mechanisms and therapy".* Nature Reviews. Neurology.9(2): 106–18.

Dana Simona Chita, Anca Tudor, Ruxandra Christodorescu et al *MTHFR Gene Polymorphisms Prevalence and Cardiovascular Risk Factors Involved in Cardioembolic Stroke Type and Severity.* Brain Sci. 2020 Aug; 10(8): 476.

A.Georgopoulos, H. Bloomfield, D. Collins et al., *"Codon 54 polymorphism of the fatty acid binding protein (FABP) 2 gene is associated with increased cardiovascular risk in the dyslipidemic diabetic participants of the Veterans Affairs HDL intervention trial (VA-HIT),"* Atherosclerosis, vol. 194, no. 1, pp. 169–174, 2007.

Chun-Jian Qiu , Xiao-Zheng Ye, Xiao-Juan Yu, Xiao-Ren Peng, Tong-Huan Li. *Association between FABP2 Ala54Thr polymorphisms and type 2 diabetes mellitus risk: a HuGE Review and Meta-Analysis* J Cell Mol Med. 2014 Dec;18(12):2530-5.

Dayana Rodrigues Farias, Nadya Helena Alves-Santos, Ilana Eshriqui et al. *Leptin gene polymorphism (rs7799039; G2548A) is associated with changes in serum lipid concentrations during pregnancy: a prospective cohort study.* Eur J Nutr. 2020 Aug;59(5):1999-2009.

Crider et al. (2011). *MTHFR 677C->T genotype is associated with folate and homocysteine concentrations in a large, population-based, double-blind trial of folic acid supplementation.* Am J Clin Nutr. 93(6):1365-1372.

Chibo Liu , Sihua Mou, Chunqin Pan. *The FTO gene rs9939609 polymorphism predicts risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis.* PLoS One. 2013 Aug 19;8(8):e71901.

Warodomwichit et al. (2009). *ADIPOQ polymorphisms, monounsaturated fatty acids, and obesity risk: the GOLDN study.* Obesity 17(3): 510-517

Hivert et al. (2008). *Common variants in the adiponectin gene (ADIPOQ) associated with plasma adiponectin levels, type 2 diabetes, and diabetes-related quantitative traits: the Framingham Offspring Study.* Diabetes 57(12): 3353-3359

Mahley RW. *Apolipoprotein E: from cardiovascular disease to neurodegenerative disorders.* J Mol Med (Berl). 2016 Jul;94(7):739-46.

Iwai C, Akita H, Kanazawa K, Shiga N, Terashima M, Matsuda Y, Takai E, Miyamoto Y, Shimizu M, Kajiya T, Hayashi T, Yokoyama M. *Arg389Gly polymorphism of the human beta1-adrenergic receptor in patients with nonfatal acute myocardial infarction.* Am Heart J. 2003 Jul;146(1):106-9.

Willer et al. (2009). *Six new loci associated with body mass index highlight a neuronal influence on body weight regulation.* Nat Genet 41(1): 25-34
Benyamin et al. (2009). *Variants in TF and HFE explain approximately 40% of genetic variation in serum-transferrin levels.* Am J Hum Genet 84(1): 60-65

Keen et al. (1999). *Association of polymorphism at the type I collagen (COL1A1) locus with reduced bone mineral density, increased fracture risk, and increased collagen turnover.* Arthritis Rheum 42(2): 285-290